

40. ÜBUNG 1 DER DICKDARMRAHMEN

DAUER : 03:16

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video wird die Praxis des Colonrahmens anhand entscheidender Stützpunkte wie der Mesenterialarterie und des linken Colonwinkels untersucht. Die Referenten betonen die Darmmotilität und ihre Verbindung zu psychischen und emotionalen Ebenen und zeigen, wie bestimmte Spannungen innere Ungleichgewichte wie Ptose oder viszerale Dysfunktionen widerspiegeln können. Die Bedeutung der abdominalen Normotension wird hervorgehoben, wobei die Probleme von Hypertonie und Hypotonie angesprochen werden. Die Verbindungen zwischen dem Colon transversum und persönlichen Gewissheiten sowie die Auswirkungen von übermäßigem Essen auf das Wohlbefinden werden ebenfalls behandelt, was Studenten und Therapeuten Schlüssel für einen integrativen und befreienden Ansatz bietet.

ÜBUNG 1: DER DICKDARMRAHMEN

In dieser Übung werden wir die wesentlichen **Stützpunkte** im Dickdarmrahmen untersuchen.

Der **erste Stützpunkt** ist die **Mesenterialarterie**. Der **zweite Stützpunkt** befindet sich am **linken Kolonflexur**, die fixiert ist. Der **dritte Stützpunkt** liegt in der Tiefe. Schließlich ist der letzte Stützpunkt mit der Dynamik des Darms verbunden, der sich in entgegengesetzter Richtung bewegt.

Die Bewegung, die wir beobachten, ist eine **Motilitätsbewegung**. Von diesem Punkt aus können wir beginnen, eine **Geschichte** zu erzählen. Ich werde sofort zum **Magen**, zur **Milz** und zur linken Kolonflexur hingezogen. Dieser Stützpunkt gleicht einen ziemlich tiefen **psychischen Plan** aus. Es ist möglich, dass er versucht, sich einem weiter vorne liegenden **Fulcrum** zu nähern, um Informationen wiederzufinden.

Dieser Punkt befindet sich im Gleichgewicht zwischen dem **Aortenplan** und dem **Milzplan**. Es ist ein Integrationsplan, ein Unbewusstes, das an die Oberfläche drängen möchte und sich in Form von **Träumen** oder **Alpträumen** äußern kann. Indem ich den Stützpunkt auf die linke Seite lege, versuche ich, eine gewisse **Freiheit** zu erlangen.

Der Endpunkt befindet sich hier. Normalerweise sollte die **epigastrische Spannung** etwas höher sein als die **hypogastrische Spannung**. Es handelt sich immer um die Suche nach **normoabdomineller Spannung** oder **hypoabdomineller Spannung**. Wenn ich bei meiner

Palpation feststelle, dass die hypogastrische Spannung höher ist als die epigastrische Spannung, deutet dies auf ein **Ptose-System** hin.

In diesem Fall muss ich an einem **viszerospatialen** oder fluiden **Rebalancing-System** arbeiten. Bei **Hypertonie** ist es notwendig, die Flüssigkeiten wieder freizusetzen. Bei **Hypotonie** hingegen ist eine Entspannung erforderlich, was bedeutet, das viszerospatiale System wieder zu integrieren, um **Dynamik** zurückzugeben und die Kraft zu erhöhen.

Es ist wichtig zu beachten, dass **Ernährungsüberschüsse** noch verbessert werden können. Beim Aufsteigen beobachte ich einen Winkel, der sich bildet, und beim Absteigen bewege ich mich in meine **Freudenzone**. Wenn die Probleme nicht gelöst werden, kann dies zur **Wutzone** führen.

Das **Querkolon** repräsentiert meine **Gewissheiten** im Leben. Wenn diese Gewissheiten nicht gelöst werden, verwandeln sie sich in **Zweifel**. Beim Aufsteigen stehe ich der **Vertrauenszone** gegenüber, wo sich meine **Ängste** befinden. Der Winkel hier ist das sogenannte **Schuldigen-Geschoss**, das unbedingt gelöst werden muss.

Schließlich, beim Absteigen, nähere ich mich der **Suche nach meiner Unabhängigkeit**, einem Prozess, bei dem ich völlig frei von meinen **Eltern** sein muss.

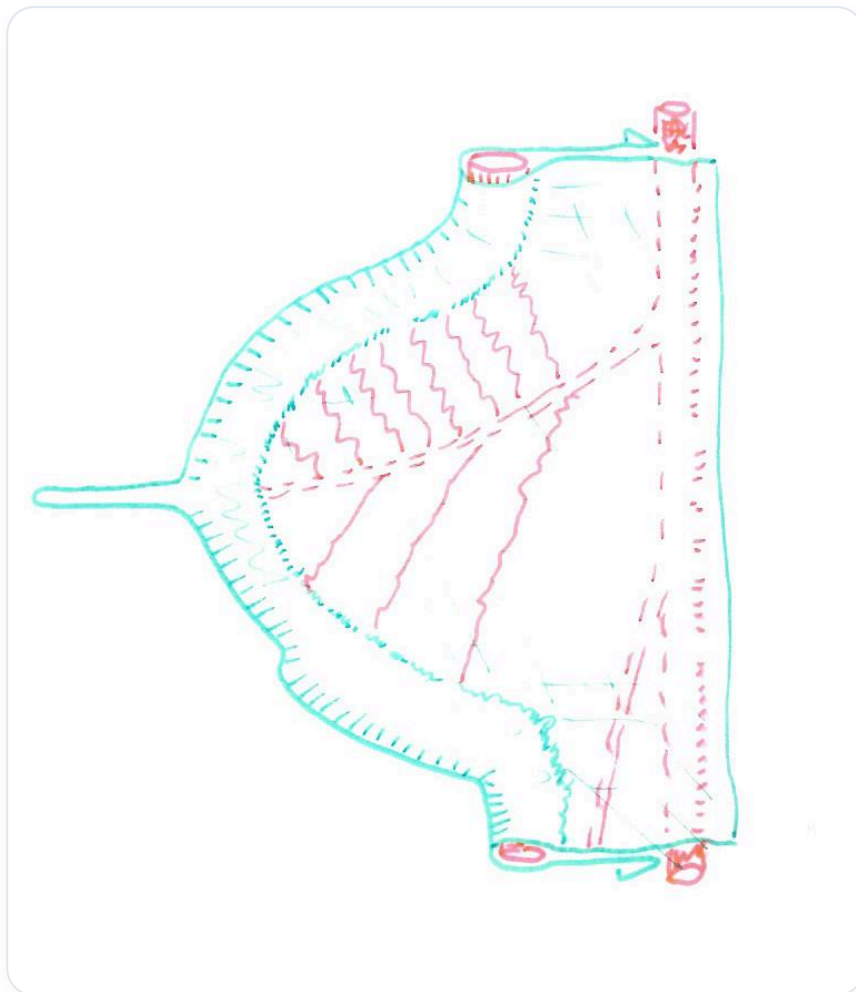


ABB. — Embryonaler Verdauungstrakt

